



Nur zur dienstlichen Verwendung

Dieser Vermerk verliert seine Gültigkeit mit der Veröffentlichung des Protokolls gemäß § 73 GOBT, spätestens jedoch nach Ablauf der jeweils nachfolgenden Wahlperiode.

Kurzprotokoll

der 5. Sitzung

Ausschuss für Gesundheit

Berlin, den 26. August 2025, 16:00 Uhr
als Zoom-Meeting.

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB

Tagesordnung



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 6

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025 – HG 2025)

BT-Drucksache 21/500

Federführend:

Haushaltsausschuss

Gutachtlich:

Innenausschuss

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Verteidigungsausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Ausschuss für Tourismus

Ausschuss für Kultur und Medien

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Tagesordnungspunkt 2

Seite 10

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025

BT-Drucksache 21/778

Federführend:

Haushaltsausschuss

Mitberatend:

Innenausschuss

Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Verteidigungsausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 3

Seite 10

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG)

BT-Drucksache 21/779

Federführend:

Haushaltsausschuss

Mitberatend:

Innenausschuss

Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

Ausschuss für Kultur und Medien

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Mitglieder des Ausschusses

Fraktionen	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Beek, Sascha van Borchardt, Simone Hiller, Dr. Matthias Janssen, Anne Müller, Axel Pauls, Dr. Thomas Pilsinger, Dr. Stephan Schmidt, Sebastian Seitz, Nora Streeck, Dr. Hendrik Theiss, Dr. Hans Weiss, Dr. Maria-Lena Zeulner, Emmi	Albani, Stephan Demuth, Ellen Ehm, Lars Grasse, Adrian Knoerig, Axel Ludwig, Dr. Saskia Müller, Sepp Reddig, Pascal Rupprecht, Albert Staffler, Katrin Stegemann, Albert Timmermann-Fechter, Astrid Walch, Siegfried
AfD	Baum, Dr. Christina Bloch, Joachim Dietz, Thomas Ebenberger, Tobias Hess, Nicole Schießl, Carina Sichert, Martin Weiss, Claudia Ziegler, Kay-Uwe	Bessin, Birgit Birghan, Dr. Christoph Bollmann, Gereon Fetsch, Thomas Giersch, Alexis L. Kempf, Martina Möller, Stefan Przygodda, Kerstin Schmidt, Dr. Paul
SPD	Machalet, Dr. Tanja Mieves, Matthias David Moll, Claudia Pantazis, Dr. Christos Schwartze, Stefan Seitzl, Dr. Lina Yüksel, Serdar	Ahmetovic, Adis Dittmar, Sabine Glöckner, Angelika Kersten, Dr. Franziska Peick, Jens Schmidt, Dagmar
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dahmen, Dr. Janosch Fischer, Simone Heitmann, Linda Kappert-Gonthier, Dr. Kirsten Wagner, Johannes	Grau, Dr. Armin Nick, Dr. Ophelia Piechotta, Dr. Paula Rietenberg, Sylvia
Die Linke	Gürpinar, Ates Merendino, Stella Schötz, Evelyn Stange, Julia-Christina	Arndt, Dr. Michael Brückner, Maik Fey, Katrin Gebel, Kathrin



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD) führt aus, dass zu Tagesordnungspunkt 1 fünf Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN und zu Tagesordnungspunkt 2 ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, ein Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN sowie ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vorlägen. Die Tagesordnungspunkte 1 bis 3 würden verbunden beraten. Die Obleute hätten angesichts der digitalen Sitzung zudem vereinbart, dass sie das Abstimmungsverhalten ihrer Fraktionskolleginnen und -kollegen stellvertretend für die jeweiligen Ausschussmitglieder abgeben. Sie stellt die Tagesordnung fest.

Tagesordnungspunkt 1

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025 – HG 2025)

BT-Drucksache 21/500

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt ein, die Gesamtausgaben des Einzelplanes 15 im Haushaltsentwurf 2025-2 beliefen sich auf 19,3 Milliarden Euro. Dies sei eine Steigerung um 2,9 Milliarden Euro gegenüber dem Entwurf 2025-1 der vorherigen Regierung. Der Anstieg sei im Wesentlichen auf das überjährige Darlehen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Höhe von 2,3 Milliarden Euro und für die soziale Pflegeversicherung (SPV) in Höhe von 0,5 Milliarden Euro zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen sei eine teilweise Stabilisierung der Sozialversicherungssysteme gelungen. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform der SPV arbeite bereits seit einigen Wochen und komme gut voran. Zeitnah werde auch die Kommission zur GKV-Reform ihre Arbeit aufnehmen. Die Pauschale für die Versicherung der Bürgergeldempfänger in der GKV sowie der Ausgleich für Corona-Belastungen in der Pflegeversicherung müssten erst besprochen werden, da es sich hierbei um strukturelle Belastungen handle. GKV und SPV bildeten mit zusammen rund 17,4 Milliarden Euro die zwei großen Posten

im Einzelplan. Dies seien rund 90 Prozent des gesamten Etats. Im Kapitel 1502 mit der Überschrift „Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung“ seien neben den Darlehen für gesetzliche Leistungen wie die Entschädigung für Hepatitis C-Opfer, Mutterschutz und die private Pflegevorsorge insgesamt rund 581 Millionen Euro veranschlagt. Für das sogenannte Präventionskapitel 1503 seien in diesem Jahr rund 960 Millionen Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren seien diese Mittel von Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Seit den Beratungen zum Haushalt 2024 ständen in diesem Kapitel auch Mittel für Modellmaßnahmen zur Versorgung von an Long-Covid leidenden Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Neu in diesem Kapitel seien Mittel für die Cybersicherheit. Im Jahr 2025 werde ein neues Sofortprogramm zur Verbesserung der Cybersicherheit im Gesundheitswesen starten, das dem Aufbau einer resilienten IT-Sicherheitsinfrastruktur dienen solle. Das Programm falle unter die Bereichsausnahme der Schuldenregel. Für die Vorbereitung des Programms im Jahr 2025 seien 2 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt betrage der finanzielle Umfang bis 2029 2 Milliarden Euro. Im Forschungskapitel seien rund 173 Millionen Euro veranschlagt. Im internationalen Gesundheitswesen, Kapitel 1505, seien rund 132 Millionen Euro etatiert, unter anderem für die WHO, UN-AIDS und das Global Health Protection Programme.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) erkundigt sich nach den Maßnahmen und Möglichkeiten, um die finanzielle Lage der GKV und SPV nachhaltig zu verbessern und zu stabilisieren.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, die kurzfristige Stabilisierung der GKV und SPV sei durch die gewährten Darlehen erreicht worden. Eine zusätzliche Entlastung der GKV um jährlich 2,5 Milliarden Euro sei durch die neue Finanzierung des Krankenhaustransformationsfonds aus einem Sondervermögen statt durch die GKV erreicht worden. Mutige Reformen würden jetzt kurz- und langfristige Maßnahmen umfassen. So werde beispielsweise ein Primärarztsystem erarbeitet, von dem sich die Regierung eine bessere Steuerung und eine Ausrichtung des Systems an den tatsächlichen medizinischen Bedarfen erhoffe. Auch solle die nicht sachgerechte



Nur zur dienstlichen Verwendung

Inanspruchnahme von Leistungen zurückgeführt werden. Im Rahmen einer Notfall- und Rettungsdienstreform, die noch um Maßnahmen zur Digitalisierung ergänzt werde, werde ein großer Einspar-effekt erwartet, unter anderem durch die Zusammenführung bzw. bessere Zusammenarbeit der Leitstellen, der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kliniken. Diese Reform solle noch in diesem Jahr angegangen werden, wobei Gespräche mit den Ländern nötig seien. Weiterhin solle die GKV-Kommission, auf die man sich im Koalitionsvertrag verständigt habe, einen engeren Zeitrahmen erhalten. Bereits im Frühjahr 2026 sollten erste Ergebnisse vorliegen, die kurzfristige Entwicklungen und Maßnahmen in den Blick nähmen, aber auch langfristige Reformvorschläge enthalten sollten. Bei der Pflegeversicherung sollten bereits Ende dieses Jahres erste Vorschläge vorliegen.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) fragt, welche weiteren Titel ebenfalls Mehrausgaben erforderten.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) betont, der Schwerpunkt des Haushalts für das Jahr 2025 sei die Stabilisierung der GKV und SPV. Da der Haushalt voraussichtlich erst Ende Oktober im Bundesgesetzblatt stehe, gebe es bis zum Jahresende kaum Spielraum, weitere Schwerpunkte zu setzen. Dies werde im nächsten Haushalt anders sein.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) fragt, welche Kürzungen in den Kapiteln Prävention und Forschung im Haushalt 2025 vorgenommen werden müssten.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die wenigen Absenkungen im Haushalt seien entweder aufgrund der langen Dauer der vorläufigen Haushaltsführung oder wegen der Einsparvorgaben des Koalitionsvertrages vorgenommen worden. Ein Beispiel seien die Kürzungen beim Ressortforschungstitel und den Mitteln für das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz - DEMIS. Obwohl die Ausgaben für Forschung, Untersuchungen und Ähnliches im Jahr 2025 auf 43 Millionen Euro steigen würden, falle der Anstieg um 5 Millionen Euro niedriger aus als im

ersten Entwurf vorgesehen gewesen sei. Zudem seien Einsparungen bei sächlichen Verwaltungsausgaben und Förderprogrammen vorgenommen worden, zum Beispiel bei den Titeln zur Stärkung der Patientensicherheit und Arzneimittelsicherheit. Die Kürzungen seien vertretbar, da die Sollausgaben für das Jahr 2025 immer noch über den Ist-Ausgaben des Jahres 2024 lägen.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) fragt nach der Finanzierung der Beitragslücke bei Bürgergeldempfängern. Er weist darauf hin, dass die Bundesregierung angekündigt habe, diese Lücke von 10 Milliarden Euro zu schließen. Er fragt, ob diese zusätzlichen Mittel durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses im Einzelplan 15 oder durch eine Erhöhung der Grundsicherung für Bürgergeldempfänger im Einzelplan 11 vorgesehen seien.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es momentan keine konkreten Vorschläge gebe. Das Thema werde in der GKV-Kommission eine Rolle spielen. Dort würden Vorschläge erarbeitet.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) erkundigt sich nach dem Zeitplan. Nach seinem Verständnis werde es weder für den Haushalt 2025 noch 2026 eine Deckung der Beitragslücke geben.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) verweist auf die Arbeit GKV-Kommission und die für Anfang nächsten Jahres zu erwartende Ergebnisse.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) fragt nach den Mitgliedern der Kommission.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Kommission zur Reform der Pflegeversicherung sei als Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit Vertretern der zuständigen Ressorts der Bundes- und Landesregierungen sowie der kommunalen Seite eingesetzt worden. Die GKV-Kommission werde voraussichtlich im September ihre Arbeit aufnehmen. Die Mitglieder seien noch nicht alle benannt.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Martin Sichert** (AfD) fragt, ob das BMG Konsequenzen aus der zu niedrigen Ausgabenveranschlagung des Schätzerkreises für die Jahre 2024 und 2025 ziehe. Die Fehleinschätzung des Schätzerkreises habe die Krankenkassen in finanzielle Bedrängnis gebracht. Er fragt, ob diese Situation einen Einfluss auf die Arbeit des Schätzerkreises habe, ob eine Neustrukturierung geplant sei oder ob es keinerlei Reaktion seitens des BMG gebe.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es für alle Beteiligten, einschließlich der Kassen und des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), schwierig sei, die tatsächliche Ausgabenentwicklung zu prognostizieren. Sie betont, dass die sehr hohe Ausgabensteigerung in diesem Jahr nicht vorhersehbar gewesen sei und dies eine Herausforderung für alle darstelle. Es sei unwahrscheinlich, durch eine Neustrukturierung des Schätzerkreises hundertprozentig sichere Zahlen zu erhalten. Der GKV-Kommission sei der Auftrag erteilt worden, die Dynamik, die Auslöser und weitere Faktoren der Kostenentwicklung grundsätzlich in den Blick zu nehmen.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) betont, dass der Haushalt 2025 auch jenseits der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen und des Bundeszuschusses für Bürgergeldempfänger Elemente zur Stabilisierung der Systeme berücksichtige. Beispiele seien der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Arzneimittel und die Dynamisierung des Bundeszuschusses. Er fragt, welches die größten haushaltspolitischen Herausforderungen seien, die beseitigt werden müssten, um die schnelle Umsetzung langfristiger Lösungen zu gewährleisten.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es gelte, gute Lösungen zu finden, ohne die Beitragszahler weiter zu belasten oder den Faktor Arbeit zu verteuern. Die größte Herausforderung sei die hohe Ausgabendynamik, vor allem im stationären Bereich. Insoweit sei ein Gesamtpaket nötig, bei dem jeder seinen Beitrag leisten müsse, um eine Entlastung des Systems durch mehr Effizienz und Steuerung zu erreichen. Dies sei wie die Quadratur des Kreises. Es gelte, die Kommissionsvorschläge abzuwarten. Die Verlagerung des Transformationsfonds sei ein erster

Schritt. Gesetze wie die Notfall- und Rettungsdienstreform oder die Einführung des Primärarztsystems müssten angegangen werden, um weitere Einsparungen zu erzielen. Gleichzeitig seien im Koalitionsvertrag auch Leistungserweiterungen vorgesehen. Es gelte, diese Ziele zu vereinen, ohne die Systeme zu überlasten.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) drückt seine Sorge über die Ausgabenentwicklung in der GKV und den Stau bei den Strukturreformen aus. Er fragt, ob die KV 45-Zahlen für das zweite Quartal 2025 bereits vorlägen und wie sich die Ausgaben der GKV in diesem Quartal entwickelt hätten.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Zahlen würden am 29. August erwartet.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erklärt, die finanzielle Situation der GKV und SPV bleibe ohne umfassende Haushaltsmaßnahmen wie den Ausgleich für Transferleistungsempfänger oder für versicherungsfremde Leistungen aus der Corona-Pandemie sehr schwierig. Er fragt nach dem genauen Zeitpunkt der Einsetzung der GKV-Kommission im September und wolle wissen, ob bereits Namen von Mitgliedern genannt werden könnten.

BMin **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) berichtet, dass die finale Abstimmung über die Mitglieder noch ausstehe.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, dass nach der abgewendeten Zahlungsunfähigkeit der Pflegeversicherung im Mai eine ähnliche Situation zum Jahresende drohe. Er fragt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung ergreifen wolle, um dies zu verhindern.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass mit dem Haushaltsentwurf und möglichen Änderungen im parlamentarischen Verfahren eine kurzfristige Stabilisierung erreicht werden könne. Darüber hinaus setze man auf die Ergebnisse und Vorschläge der



Nur zur dienstlichen Verwendung

Kommission.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ergänzt, im Kabinettsverfahren seien keine Haushaltsmittel zum Ausgleich der Defizite in der GKV durchsetzbar gewesen. Er hoffe, dass dies im parlamentarischen Verfahren gelinge. Er fragt, wann mit den Referentenentwürfen für die Notfallreform und dem Primärarztssystem zu rechnen sei.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) stellt klar, sie habe nicht gesagt, dass die Zusammensetzung oder der Starttermin der Kommission unbekannt seien, sondern dass sie dazu im Moment keine Details nennen könne. Derzeit werde am Referentenentwurf für die Notfall- und Rettungsdienstreform gearbeitet, der um Elemente der Digitalisierung ergänzt werde. Auch gebe es noch Gesprächsbedarf mit den Ländern. Sie gehe davon aus, die Gespräche im Herbst finalisieren zu können und dann den Entwurf vorzulegen. Zum Primärarztssystem führe das BMG zunächst Gespräche mit den Interessengruppen über die erarbeiteten Eckpunkte, weshalb der Referentenentwurf noch einige Zeit in Anspruch nehme.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) weist darauf hin, dass die Kommission die Darlehen, die bis Ende 2029 zurückgezahlt werden müssten, berücksichtigen müsse. Er fragt, ob die Ministerin davon ausgehe, dass die Kommission die aktuelle Beitrags- und Kostenentwicklung sowie die Darlehen so berücksichtigen könne, dass eine stabile Entwicklung der GKV gewährleistet sei. Er wolle wissen, ob die Regierung die Lösung dieses großen Problems allein der Kommission überlassen wolle oder ob bereits jetzt Vorschläge zur Rückzahlung der Darlehen vorlägen.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Darlehen seien ab 2029 zurückzuzahlen. Sie gehe davon aus, dass die Darlehen nicht die größte Herausforderung für die Expertenkommission darstellen würden. Sie verweise auf weitere Maßnahmen wie das Primärarztssystem und die Notfall- und Rettungsdienstreform, die parallel erarbeitet würden und Einsparungen mit sich brächten. Es gelte, die Kostenentwicklung in den Versicherungssystemen anzugehen, die

weitreichende Reformen erforderten. Die Herausforderung bestehe darin, die Darlehen, die Ausgabendynamik sowie die nicht gegenfinanzierten Leistungen für Bürgergeldempfänger und versicherungsfremde Leistungen in einer Gesamtlösung zu berücksichtigen. Sie sei zuversichtlich, dass die Kommission dieser Aufgabe gerecht werde.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) kritisiert, dass sich die Bundesregierung bislang weder auf eine nachhaltige Beitragserhebung noch auf einen echten Steuerzuschuss habe einigen können. Er mutmaße, dass die Regierung entweder von einer kurzfristigen Entspannung der Lage ausgehe oder glaube, dass die Kommission alle Probleme lösen werde, einschließlich der Rückzahlung der Darlehen bis Ende 2029. Er fragt, ob die Kommission auch die Möglichkeit von Leistungskürzungen prüfen dürfe oder ob dieser Weg für sie ausgeschlossen sei.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Kommission solle ohne Denkverbote und vorurteilsfrei beraten. Es gebe verschiedene Vorschläge, die öffentlich diskutiert würden, und es sei wichtig, keinen bereits vor Beginn der Kommissionsarbeit abzulehnen. Es gelte, alle Aspekte zu berücksichtigen. Sie spreche sich für ein Gesamtpaket aus, das nicht nur einseitig belaste. Es sei zu einfach, die Probleme allein durch die Erhöhung von Beiträgen oder der Beitragsbemessungsgrenzen zu lösen. Stattdessen müssten mehr Effizienz und Steuerung ins System gebracht werden. Das Primärarztssystem sei hierbei ein wichtiger Baustein, aber es bedürfe weiterer Vorschläge.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) ergänzt, dass voraussichtlich eine neue Regierung im Amt sei, wenn die Darlehen 2029 fällig würden. Er fragt, ob es Alternativszenarien für die Frist gegeben habe und wie das BMG genau auf das Jahr 2029 gekommen sei.

BMn **Nina Warken** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dies sei das Ergebnis von Gesprächen mit dem BMF gewesen.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt die Änderungsanträge seiner Fraktion zum Haushaltsgesetz auf Ausschussdrucksache 21(14)15¹ ein.

Tagesordnungspunkt 2

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025

BT-Drucksache 21/778

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) führt zum Gesetzentwurf und zum Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(8)296² aus, das Haushaltsbegleitgesetz diene vorrangig haushaltsrechtlichen Anpassungen und enthalte wichtige Sonderregelungen für Krankenhäuser und die GKV-Financen. Es gehe darum, die Lücke aus den Jahren 2022 und 2023 zu schließen. Die Finanzierung solle über einen befristeten Rechnungszuschlag erfolgen, der vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 gelte. Dieser Zuschlag liege bei 3,45 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent auf den Rechnungsbetrag bei GKV-versicherten Patientinnen und Patienten. Der finale Wert unterliege dem Aktualisierungsvorbehalt des BMG und solle vor der Bereinigungssitzung am 4. September 2026 festgestellt werden. Die Abwicklung solle bürokratiearm über bestehende Abrechnungssysteme ablaufen. Dabei gebe es hinsichtlich des Auszahlungsmechanismus noch Gesprächsbedarf. Des Weiteren seien ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds vorgesehen, und zwar 1,5 Milliarden Euro für 2025 und 2,5 Milliarden Euro für 2026. Die Zuschüsse gleichen die Belastung der Krankenkassen durch die Rechnungszuschläge aus. Der Nettoeffekt sei, dass für die GKV keine weiteren Mehrausgaben entstünden.

Die landwirtschaftliche Krankenkasse erhalte Sonderzuweisungen von 14 Millionen Euro im Jahr 2025 und 24 Millionen Euro im Jahr 2026. Zudem sei die Vermeidung von Doppelvergütungen bei Hybrid-DRGs (Diagnosis Related Groups) enthalten. Das Problem sei, dass Fälle, die künftig mit Hybrid-DRGs vergütet würden, bisher zusätzlich in den

Vorhalte-Volumina berücksichtigt worden seien. Die Lösung sei, dass die Hybrid-DRGs-Fälle bei Vorhaltekalkulationen nicht mehr berücksichtigt würden. So würden Mehrausgaben für die GKV ab 2026 im dreistelligen Millionenbereich verhindert. Die finanziellen Auswirkungen umfassten Mehrausgaben für den Bund von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 und 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2026, welche die Zuschüsse an den Gesundheitsfonds abdeckten. Bei den Krankenkassen seien insgesamt Rechnungszuschläge von 4 Milliarden Euro geplant, und die Gegenfinanzierung erfolge dementsprechend.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) führt den Änderungsantrag ihrer Fraktion auf Ausschussdrucksache 21(14)14³ ein.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt den Änderungsantrag seiner Fraktion auf Ausschussdrucksache 21(14)16⁴ ein.

Tagesordnungspunkt 3

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG)

BT-Drucksache 21/779

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) führt zum Gesetzentwurf aus, dass Bund, Länder und Kommunen vor immensen Aufgaben stünden. Nach den Krisen der vergangenen Jahre und angesichts neuer Herausforderungen bestünden große Finanzierungsbedarfe, die unabhängig von der konjunkturellen Lage zu decken seien. Diese erstreckten sich unter anderem auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, in die Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, in den Erhalt und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie im Gesundheitsbereich auf Investitionen in die Transformation und Modernisierung der

¹ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)15

² Anlage: Ausschussdrucksache 21(8)296

³ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)14

⁴ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)16



Nur zur dienstlichen Verwendung

Krankenhausinfrastruktur. Die Infrastruktur sei ein maßgeblicher Standortfaktor, der die Wettbewerbsfähigkeit und die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Landes beeinflusse. Der notwendige gesamtwirtschaftliche Investitionsbedarf sei in verschiedenen Studien auf einen mittleren bis hohen dreistelligen Milliardenbetrag in den kommenden zehn Jahren geschätzt worden. Man wolle daher mit dem Gesetzentwurf ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung von bis zu 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 errichten. Investitionen aus dem Sondervermögen könnten innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden. Wie im Grundgesetz (GG) festgelegt, erhalte der Klimatransformationfonds eine Zuführung von insgesamt 100 Milliarden Euro. Ferner sollten auch den Ländern 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Einrichtung des Sondervermögens sichere eine langfristige Finanzierungsgrundlage für Investitionen zur Modernisierung Deutschlands und werde dem Bund eine Investitionsoffensive als integralen Bestandteil eines umfassenden Wachstums- und Investitionspakets ermöglichen.

Im Gesundheitsbereich werde es dank des Sondervermögens ermöglicht, dass der Transformationfonds nicht mehr aus Beitragsmitteln der GKV, sondern aus Steuergeldern finanziert werde. Damit leiste man auch einen Beitrag zur finanziellen Stabilisierung der GKV.

Die **Vorsitzende** weist darauf hin, dass nun zu den beiden Gesetzentwürfen der Koalitionsfraktionen Fragen an die Bundesregierung gerichtet werden könnten.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) verzichtet für ihre Fraktion auf Fragen.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD) fragt, ob die Bundesregierung trotz des ergänzenden Bundeszuschusses von 4 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds mit einer Erhöhung der Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen im Jahr 2026 rechne, da bereits 15 Krankenkassen im Jahr 2025 die Zusatzbeiträge erhöht hätten.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass man eine Steigerung weder ausschließen noch sicher annehmen könne. Er verweise darauf, dass die entsprechenden Erkenntnisse in den kommenden Wochen durch den Schätzerkreis erhoben und bearbeitet würden. Man befinde sich in der Beobachtungsphase und werde daraus die notwendigen weiteren Maßnahmen entwickeln müssen, möglicherweise auch sehr kurzfristig. Der Prozess sei im Moment hochdynamisch und werde vom BMG sehr aufmerksam beobachtet.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD) fragt, mit welchen zusätzlichen Belastungen für den Gesundheitsfonds zu rechnen sei, da die Kliniken in der Zeit vom 1. November 2025 bis Ende Oktober 2026 einen Rechnungszuschlag von 3,45 Prozent erheben dürften. Dies stelle er vor dem Hintergrund in Frage, dass laut Aussagen der Bundesregierung die Mehrkosten durch die zusätzlichen Bundeszuschüsse in den Jahren 2025 und 2026 abgedeckt sein sollten.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass der Prozentsatz abgesenkt werde, damit es im Hinblick auf die bisherigen Vorausberechnungen nicht zu entsprechenden Mehrbelastungen komme.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) fragt, welche Rechtsfolge eintrete, wenn der vorgesehene ergänzende Bundeszuschuss von 4 Milliarden Euro für den Gesundheitsfonds vor dem 31. Oktober 2026 verbraucht sein sollte und ob in diesem Zusammenhang ein Finanzierungsrisiko für die GKV bestehe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass rein theoretisch ein finanzielles Restrisiko für die GKV bestehen könne. Dies hänge entscheidend davon ab, wie sich die Grundrechnungsbeträge entwickeln würden. Man könne die Befürchtungen bezüglich einer künstlichen Steigerung der Rechnungsbeträge weder bestätigen noch dementieren. Er gehe aber nicht davon aus, dass binnen kürzester Zeit maßgeblich gestalterische Einflüsse auf die Rechnungsbeträge im legalen Raum genommen werden könnten. Er sehe aber, auch im Hinblick auf die



Nur zur dienstlichen Verwendung

Kritikpunkte, die Notwendigkeit, den Krankenhäusern jetzt eine entsprechende Liquiditätssicherung zu geben. Er glaube nicht, dass zwischen systemrelevanten beziehungsweise versorgungsrelevanten Häusern und sonstigen Häusern unterschieden werden könne. Dies könnte vom jetzigen Standpunkt aus nur mit einem sehr großen Aufwand beurteilt werden und werde dem Transformationszeitraum möglicherweise nicht gerecht.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) weist darauf hin, dass die Höhe des vorgesehenen Rechnungszuschlages unter Aktualisierungsvorbehalt gestellt werde. Er fragt, ob die Bundesregierung bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens in der Lage sein werde, einen finalen Wert zu übermitteln. Dies sei für die Planungssicherheit der Krankenhäuser wichtig.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, er gehe davon aus, dass die Bundesregierung in der Lage sein werde, einen finalen Wert zu übermitteln. Stichtag sei der 29. August. Die Daten würden dann unverzüglich in die entsprechenden Gesetzgebungszahlen umgearbeitet.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zeigt sich besorgt, dass weder bestätigt noch dementiert werden könne, ob ein Restrisiko für die GKV bestehe. Durch Fallzahlsteigerungen könne natürlich Einfluss genommen werden. Dies gelinge besonders gut in städtisch überversorgten Regionen. Unter einer solchen Regelung litten ländliche Krankenhäuser der Basis- und Grundversorgung, die benachteiligt würden. Die Regelung sei nicht geeignet, kurzfristig für Liquidität zu sorgen. Rechnungen würden Monate, teilweise Jahre später gestellt und nicht sofort. Er fügt hinzu, dass, wenn Liquidität für die Krankenhäuser geschaffen werden solle, eine Regelung per Zuschlag sinnvoll sei, bei der das Geld sofort oder zu zwei Terminen ausgeschüttet würde. Er fragt, wie sichergestellt werden solle, dass mit dieser Regelung nur Kliniken profitierten, die auch in Zukunft gebraucht würden.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erwidert, dass die Situation keineswegs sorglos betrachtet werde und man

Risiken sehe und bewerte. Bezüglich der Befürchtungen über eine Steigerung der Fallzahlen habe er darauf hingewiesen, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser durch Personaluntergrenzen und tatsächliche Kapazitäten begrenzt seien. Die Auslastung lasse sich nicht beliebig in einem kurzen Zeitraum verändern, zumal es dazu auch Patienten mit einem objektiv feststellbaren Behandlungsbedarf geben müsse. Er wolle manipulatives Potenzial nicht ausschließen, gehe aber nicht davon aus, dass in einem normal geführten Haus in dieser Kürze der Zeit grundlegend in die Versorgungsstruktur eingegriffen werden könne. Im Hinblick auf die Versorgungsrelevanz der Krankenhäuser sei die Bestandssituation momentan hochsensibel. Fast alle Häuser befänden sich in einer kritischen Liquiditäts- und Einnahmesituation, da die Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) belegten, dass 80 bis 85 Prozent der Häuser rote Zahlen schrieben. Wenn man allein von diesem Aspekt ausgehe, sei die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer unberechtigten Einnahmesteigerung komme, fast zu vernachlässigen. Die Frage der Bestandskraft und Versorgungsrelevanz der Häuser werde im Augenblick einer Prüfung unterzogen.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) fragt, warum die Bundesregierung für die Auszahlung der Soforthilfen für Krankenhäuser einen Auszahlungsmechanismus nutze, bei dem die Rechnungszuschläge auch denjenigen Kliniken zugutekämen, die in den vergangenen Jahren Gewinne gemacht hätten. Sie fragt, wie die Bundesregierung sicherstellen wolle, dass die Soforthilfen nur den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt würden, die für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig seien und sich tatsächlich in einer finanziellen Notlage befänden.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass er die Hypothese, die Krankenhäuser hätten in der Vergangenheit in unübersehbarem Umfang Gewinne erzielt, nicht teile. Das Gegenteil sei der Fall. Die Zahlen der DKG deuteten darauf hin, dass die Existenz einer Vielzahl von Krankenhäusern aktuell gefährdet sei. Er betont, dass es im Hinblick auf die Treffsicherheit derzeit einen akuten Handlungsdruck gebe. Bevor man eine ausführliche Analyse von Abrechnungsunterlagen aus vergangenen Jahren vorgenommen habe, sei der relevante Zeitraum, in



Nur zur dienstlichen Verwendung

dem die Hilfe benötigt werde, möglicherweise verstrichen. Dies würde das Risiko einer „kalten Bereinigung“ mit sich bringen, dem massiv entgegenge wirkt werden solle.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) fragt, inwiefern die vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro für 2025 und 2,5 Milliarden Euro für 2026 auf der Ermittlung tatsächlicher finanzieller Bedarfe beruhten, wie die Defizite der Krankenhäuser genau ermittelt worden seien und auf welcher Grundlage die Bemessung des Gesamtfinanzvolumens beruhe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, er habe die Frage akustisch nicht verstanden.

Die **Vorsitzende** weist darauf hin, dass die Fragezeit der Fraktion Die Linke aufgebraucht sei und bittet um die Positionierung zu den drei Gesetzentwürfen.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) führt aus, dass die Gesetzentwürfe die Krankenhäuser kurzfristig entlasteten und die Transformationslücken schlossen. Dies stärke die Planungssicherheit in der Krankenhausfinanzierung. Zudem verhindere das Gesetz Kostenexplosionen bei GKV und PKV durch die Klarstellung bezüglich der Hybrid-DRGs und signalisiere nach außen, dass die Krankenhausfinanzierung ein zentrales Handlungsfeld der Bundesregierung bleibe. Gleichzeitig schaffe das Sondervermögen Planungssicherheit für langfristige Investitionen in die Gesundheitsversorgung. Es signalisiere, dass das Gesundheitssystem Teil der gesamtgesellschaftlichen Zukunftsinvestitionen wie Infrastruktur, Klimaschutz und Forschung sei und ermögliche damit strukturelle Anpassungen im Krankenhauswesen und in der Daseinsvorsorge.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) führt aus, es sei fatal für das Vertrauen der Bürger in die Regierung und das Parlament, wenn der Bundeskanzler und die Gesundheitsministerin ankündigten, dass die Beitragslücke, die durch Bürgergeldempfänger in der GKV entstehe, geschlossen werde, dies aber weder im aktuellen noch im nächsten Haushalt vorgesehen sei. Der gesamte Haushalt habe keine

langfristig stabilisierende Perspektive, sondern sei nur Flickschusterei. Daher lehne seine Fraktion den Haushalt ab.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) führt aus, der Haushalt des BMG sei immer noch von der Verantwortung geprägt, die das BMG in der Pandemie übernommen habe, insbesondere bei Beschaffungen und Pandemieberatungsverträgen. Der Steuerzuschuss sei und bleibe der größte Posten. Die Fraktion der SPD sei der Auffassung, dass der Bundeshaushalt mehr Verantwortung für die Sozialversicherung übernehmen solle. Dazu müsste auch die Einnahmesituation des Bundes strukturell gestärkt werden. Er könne die Wünsche im Änderungsantrag der Grünen teilweise nachvollziehen. Diese seien jedoch zu kleinteilig für die Verhandlungen in einer Bereinigungssitzung. Man lehne daher den Änderungsantrag der Grünen ab und stimme dem Gesetzentwurf zu.

Beim Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes begrüße die Fraktion der SPD die ergänzenden Bundeszuschüsse für den Gesundheitsfonds zur Stärkung und zum Ausgleich von Investitionen in die Krankenhauslandschaft. Gleichwohl sei die Kritik an der Auszahlung per Rechnungszuschlag nachvollziehbar und auch der Bundesrechnungshof habe den Mechanismus kritisiert. Es müsse sichergestellt werden, dass die knappen Mittel zielgenau und zukunftsträchtig eingesetzt würden. Das Geld solle an diejenigen Kliniken fließen, die wirklich Defizite gemacht hätten, die aber auch zukünftig die Versorgung übernehmen sollten.

Der Änderungsantrag der Grünen greife hier ebenfalls die Anforderungen und Kritik auf. Der Vorschlag, bestehende Instrumente wie die Sicherstellungs-, Notfallstufen- oder Zentrumsfinanzierung zu nutzen, sei interessant, scheine im Detail aber nicht ausgereift. Auch der Änderungsantrag der Linken treffe grundsätzlich den Ton. Das vorgeschlagene Defizitausgleichsverfahren sei jedoch zu bürokratisch und letztlich zu langsam, da die Häuser die Mittel zeitnah benötigten. Man lehne daher beide Änderungsanträge der Opposition zu Tagesordnungspunkt 2 ab.

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sei das größte Investitionsvolumen in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Dank gelte dem Koalitionspartner CDU/CSU und den Grünen. Erst durch die gemeinsame GG-Änderung sei das Sondervermögen möglich geworden. Die Infrastruktur



Nur zur dienstlichen Verwendung

sei ein wichtiger Standortfaktor, der die Wettbewerbsfähigkeit und die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Landes maßgeblich beeinflusse. Im Gesundheitsbereich ermögliche das Sondervermögen, den Transformationsfonds zur Krankenhausreform aus Steuermitteln zu finanzieren. Dies sei gut und richtig, da Investitionen in Infrastruktur keine Aufgabe der GKV seien.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont, dass viele der angekündigten und im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben bisher nicht umgesetzt worden seien. Die Sozialversicherungen, insbesondere die GKV und die SPV, befänden sich in einer dramatisch schwierigen Situation. Er kritisiert, dass Ankündigungen zum Ausgleich der beitragsfreien Mitversicherung von Transferleistungsempfängern bisher nicht im Kabinettsverfahren vereinbart worden seien. Es sei unrealistisch und unredlich, dass die Ministerin ihren Koalitionsfraktionen eine solche Aufgabe aufbürde. Dies seien Versprechen, die nicht eingehalten werden könnten.

Es sei offensichtlich, dass die Beiträge für die GKV und die SPV weiter stark steigen würden. Die Menschen merkten bereits, in welcher schwieriger Schieflage sich die Sozialversicherungen befänden. Es befremde ihn, dass die Kommissionen zur Unterstützung erst im September eingesetzt und erste Ergebnisse erst 2026 oder 2027 vorliegen würden. Auch beim Haushalt 2025 bleibe die Koalition hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Die Änderungsanträge der Grünen, die Prävention, Drogen- und Suchtaufklärung sowie die Unterstützung der WHO auf dem bisherigen Niveau fortführen wollten, seien vernunftgeleitet und keine unrealistischen Forderungen.

Seine Fraktion habe die Änderung des GG zur Errichtung der Sondervermögen mitbeschlossen, aber es verstehe niemand, wenn das Kriterium der Zusatzlichkeit nicht eingehalten werde. Es nütze nichts, wenn Aufgaben aus dem Kernhaushalt einfach in den Bereich des Sondervermögens verschoben würden, um Haushaltsspielräume zu schaffen. Es sei nicht richtig, 4 Milliarden Euro als Liquiditätshilfe aus einem Sondervermögen zu finanzieren. Es sei zudem absolut untypisch und undenkbar, 4 Milliarden auszugeben, ohne eine sachgerechte Anhörung abzuhalten. Im federführenden Haushaltsausschuss sei nicht ein Sachverständiger aus dem Gesundheitswesen geladen worden. Man

bleibe sehr kritisch, aber konstruktiv und hoffe, dass die Koalition im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen erreichen werde.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) kritisiert die Gesetzentwürfe als eine massive Umverteilung von unten nach oben, weshalb seine Fraktion dagegen stimmen werde. Im Gesundheitsbereich finde eine weitere Ausdünnung der Infrastruktur statt, da die Hilfen so gestaltet seien, dass sie die bestehende Infrastruktur nicht schützten. Die Gelder würden nach dem Gießkannenprinzip ausgegeben. Dies führe dazu, dass diejenigen, die sich eine gute Gesundheitsinfrastruktur leisten könnten, diese weiter nutzten, während diejenigen, die auf die öffentliche Infrastruktur angewiesen seien, das Nachsehen hätten. Die von der Koalition vorgeschlagenen Lösungen verschoben die Probleme in die Zukunft. Das Darlehen müsse von einer nächsten Regierung zurückgezahlt werden.

Die geplante Kommission müsse eine Quadratur des Kreises vornehmen, was nicht möglich sei, wenn man keine grundlegende Reform angehe. Um das Gesundheitssystem zu stärken, müsse eine Kasse geschaffen werden, in die alle einzahlten. Die Regierung drücke sich davor und verschiebe die Probleme in eine Kommission und verlagere sie damit in die Zukunft. Zum Sondervermögen sei anzumerken, dass die Summe auf zwölf Jahre gestreckt werde und die 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen nicht ausreichen. Allein die Kommunen benötigten laut einer Rechnung der Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,15 Milliarden Euro. Wenn Steuermittel der Kommunen durch das Sondervermögen verringert würden und Teile des Kernhaushalts finanziert werden sollten, sei das Sondervermögen nur ein schönes Bild, das nichts zur Stärkung der Infrastruktur im Land beitrage. Die Änderungsanträge der Grünen zum grundlegenden Haushalt seien weitgehend zustimmungsfähig. Den vorliegenden Änderungsantrag der Grünen zu den anderen Gesetzen finde man ebenfalls spannend, aber die Linke werde sich in diesem Punkt enthalten.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Änderungsanträge 1, 2, 4 und 5 auf Ausschussdrucksache 21(14)15



Nur zur dienstlichen Verwendung

abzulehnen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, den Änderungsantrag 3 auf Ausschussdrucksache 21(14)15 abzulehnen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, dem Plenum des Deutschen Bundestages die Annahme des Haushaltsgesetzes auf Drucksache 21/500 zu empfehlen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(14)14 abzulehnen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, den Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(14)16 abzulehnen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, den Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(8)296 anzunehmen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, dem Plenum des Deutschen Bundestages die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/778 in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung zu empfehlen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN und Die Linke, dem Plenum des Deutschen Bundestages die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/779 zu empfehlen.

Schluss der Sitzung: 17:35 Uhr

gez.

Dr. Tanja Machalet, MdB
Vorsitzende